

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1208/I-KEP/DIR/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN PROFIL RISIKO RUMAH SAKIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan adanya kebijakan tentang Penetapan Profil Risiko Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Profil Risiko Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1354/2024 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107/Menkes/1596/2024 tentang Standard Akreditasi RS
12. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG TENTANG PROFIL RISIKO RUMAH SAKIT
Kedua : Masa berlaku profil risiko dan mitigasi risiko yakni 01 Januari 2026 –
31 Desember 2026 sebagaimana dimaksud Diketum adalah selama
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan pada peraturan ini, maka
akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 31 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 1208/I-KEP/DIR/XII/2025
TENTANG PENETAPAN
PROFIL RISIKO RUMAH SAKIT

PROFIL RISIKO

No	KATEGORI RISIKO	IDENTIFIKASI RISIKO						PERINGKAT RISIKO
		PERNYATAAN RISIKO	AKAR MASALAH	DAMPAK	PROBABILITAS	CONCAT (D & P)	SKOR	
1	Operasional	Jika petugas tidak melakukan pemeliharaan alat, maka berisiko alat rusak, sehingga pelayanan dapat terganggu	Belum optimalnya pemantauan jadwal preventive maintenance alat.	4	5	45	20	1
2	Klinis	Jika terjadi miskomunikasi antar tenaga kesehatan maka dapat menyebabkan kesalahan terapi dan tindakan yang tidak sesuai pada pasien	Komunikasi efektif belum dilaksanakan secara konsisten (SBAR), proses handover belum optimal, serta informasi klinis pasien tidak tersampaikan secara lengkap dan tepat waktu.	4	5	45	20	2
3	Operasional	Jika downtime sistem berisiko pelayanan terhambat dan berakibat tidak dilayaninya pasien	Gangguan jaringan dan server, belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, serta belum tersedianya sistem	4	4	44	16	3

			cadangan (backup system) yang memadai.					
4	Operasional	Jika sistem e-klaim terganggu maka proses klaim tertunda dan berdampak pada keuangan rumah sakit	Ketergantungan pada sistem bridging eksternal, gangguan koneksi jaringan, perubahan regulasi aplikasi e-klaim, serta keterbatasan kemampuan petugas dalam penanganan troubleshooting.	5	3	53	15	4
5	Klinis	Jika tidak teliti, beresiko salah input e-resep dan menimbulkan cedera	Kurangnya ketelitian petugas saat memasukkan resep elektronik, tingginya beban kerja, kemiripan nama obat (LASA), serta kurang optimalnya proses verifikasi resep sebelum dispensing.	5	3	53	15	5

RENCANA PENANGANAN RISIKO

No	Kegiatan	Sasaran	Risiko (Prioritas/Sangat Tinggi)	Alternatif Teknik Penanganan Risiko		Pengendalian Yang Sudah Ada			Rencana Pengendalian			Pemilik Risiko	PJ TL Pengendalian
				Opsi Teknik Penanganan Risiko	Uraian Penanganan Risiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Efektif/Kurang Efektif	Pengendalian Yang Harus Ada	Kegiatan	Waktu	Jenis (Detektif (D), Preventif (P), Korektif (K))		
1	Pengelolaan Pemeliharaan Alat Medis	Seluruh alat medis berfungsi optimal	Kerusakan alat akibat tidak dilakukan pemeliharaan	Mitigasi	Monitoring pelaksanaan preventive maintenance dan kalibrasi alat	SPO Pemeliharaan Alat	Kurang Efektif	Checklist pemeliharaan, monitoring kepatuhan jadwal, evaluasi bulanan alat	Audit kepatuhan pemeliharaan alat dan monitoring preventive maintenance	Bulanan	Preventif	IPSRS	Karu IPSRS
2	Peningkatan Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan	Seluruh tenaga kesehatan	Kesalahan komunikasi klinis yang menyebabkan kesalahan terapi/tindakan	Mitigasi	Pelatihan komunikasi efektif, supervisi handover, audit SBAR dan briefing-debriefing	SBAR, TulBaKon, handover terstruktur	Kurang Efektif	Audit kepatuhan SBAR, checklist handover, supervisi rutin	Audit komunikasi efektif dan pelatihan refreshment SBAR	Triwulan	Preventif	IGD	Kepala IGD dan Komite PMKP
3	Penguatan Sistem Teknologi Informasi Rumah Sakit	Sistem informasi rumah sakit	Downtime server atau sistem lambat	Mitigasi	Maintenance server, backup data, monitoring jaringan, simulasi downtime	Pemeliharaan server berkala	Kurang Efektif	Server backup, monitoring real time, evaluasi kapasitas server	Monitoring performa server dan simulasi downtime	Bulanan	Preventif	IT	Kepala IT

4	Pengendalian Risiko Gangguan E-Klaim BPJS	Proses klaim BPJS	Kegagalan proses klaim yang menyebabkan klaim tertunda	Berbagi Risiko	Monitoring sistem, koordinasi dengan BPJS dan IT, backup proses manual	Monitoring IT	Kurang Efektif	Audit klaim	Audit klaim BPJS	Bulanan	Detektif	Asuransi Center	Karu Asuransi Center
5	Peningkatan Keamanan Proses E-Resep	Proses peresepan elektronik	Kesalahan input e-resep yang berpotensi menyebabkan cedera pasien	Mitigasi	Validasi resep oleh apoteker, double check obat, pelatihan penggunaan e-resep dan pemanfaatan sistem alert	SPO Penulisan dan Input Resep	Kurang Efektif	Audit resep elektronik, penguatan clinical decision support dan double verification	Audit kepatuhan e-resep dan monitoring medication error	Bulanan	Preventif	Farmasi	Kains Farmasi

Mengetahui,
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M. Kes

Malang, 31 Desember 2025
Ketua Komite PMKP



dr. Ari Putriani, Sp. PK